EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90360
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-09 14:05:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RAUL ENRIQUE ARAVENA ZAMORANO			RUN	: 13.601.234-7
F.Nac	: 26-09-1978	Edad	: 45 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: VENUS 3			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 987704656		
Fecha Ingreso	: 2024-07-30	Fecha Egreso	: 2024-08-09 14:05:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DHC por OH descompensado Child C 13 puntos, Meld Na 40 puntos
Encefalopatía hepática grado 2
LRA KDIGO 3 no oligurica
OH suspendido

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos, OH suspendido hace 2 meses, es traído por familiares el 28.07.24 a SU HSC por cuadro de un día de evolución caracterizado por compromiso del estado general, aumento de ictericia, desorientación temporo espacial y eventual oliguria en domicilio.
En SU se solicita TAC cerebro s/c que no evidencia lesiones agudas
Dentro de exámenes de ingreso destaca crea 4.5, BT 14.7, BD 9.04, lactato 5.4, PCR 28, amonio 250, ELP 136/5.1/104, Hb 8.8, Hto 26.4, plaquetas 103 mil, INR 2.96, TP 25%, TTPK 53.
Se solicita hemocultivo + urocultivo y se inicia tto ATB empírico con ceftriaxona.
Cursa con compromiso HD con respuesta parcial a volumen.
Se solicita evaluación por residente UTI y se constata paciente en malas condiciones generales, afebril, con hemodinamia límite, desorientado en tiempo y espacio, en GCS 11 puntos; por lo que se decide ingreso a unidad para monitorización y manejo.
Actualmente
Paciente refiere sentirse en mejores condiciones generales.
Sin episodios de desorientación nocturna. con al menos 1 episodio de defecación en el día. Recibiendo terapia ATB acorde en contexto clínico.
Se iniciará BBLOQ baja dosis
Eventual alta médica AM: cumplimiento ATB al menos 10 días con rotación de terapia VO.
Examen físico:
Vigil, levemente bradpsiquico, más orientado.
Pupilas isocóricas, RFM+ simétrico, sin déficit motor Flapping(+)
Piel y conjuntivas ictericia +++, hidratación NORMAL
llene cap 2 seg, MS 0
RR2TNAS
mp+ simétrico SRA eupneico. Se denotan petequias en región supraclavicular y toracica superior.
Abd: globuloso RHA+ blando, depresible, sin dolor a la palpación.
EEII con edema pretibial EID leve. Ortejo mayor derecho con eritema periungueal y onicocriptosis + ornicomicosis

SE CONVERSA CON FAMILIAR Y SE DECIDE TRATAMIENTO EN HODOM PARA COMPLETAR TRATAMIENTO ATB POR 14 DIAS Y AL ALTA IC CON CIRUGIA POR ONICOCRIPTOSIS

PLAN DE MANEJO:

Infeccioso: HC+ Streptococcus pyógenes Grupo A, manejo con ceftriaxona + metronidazol. Se realizó contacto para profilaxis a contactos estrechos. Sospecha de descompensación por patología biliar, por ahora fuera de alcance quirúrgico dada condiciones basales del paciente (evualado por cirugía).
Eco doppler para descarte de TVP/ celulitis. Mantener tto. antibiótico. IC Cirugía eventual ornisectomía parcial ortejo mayor der. AL ALTA

Renal: LRA KDIGO 3 resuelta, con buena respuesta a volumen y albúmina, sin trastorno HE asociado, evitar nefrotóxicos, seguimiento a diario función renal. Evitar nefrotóxicos.

Gastro: DHC Child C, hallazgo y trasposición por OH. Iniciar betabloqueo . Asegurar 2 a 3 deposiciones diarias. Se indica realizar fleet enema

Neuro: manejo de encefalopatía. Inicio rifaximina.
Metabólico: Regimen blando.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo | Contención SOS | PUPP
2. Régimen Papilla con sal, asistido | Favorecer hidratación VO
3. FiO2 para sat > ó = 92% SOS
4. Ceftriaxona 2 gr/día ev (10/14) COMPLETAR 14 DIAS
5. Metronidazol 500 mg cada 8 horas VO (9/14)
6. Rifaximina 200 mg 2 comprimidos c/8h vo
7. Propanolol 10mg vo c12h
8. Omeprazol 20 mg VO.
9. Haldol 1mg vo c24h SOS
10. PEG 1 sobre c/12 hrs vo para 2-3 deposiciones al día
11. Enema Lactulosa c12h SOS no deposiciones en 12h
12. Control SV c8h.

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXAMENES DE LAB
Recuento de leucocitos : 11,70 * mil/ul
Recuento Hematies : 2,33 * Mill/ul
Hematocrito : 25,6 * o/o
Hemoglobina : 9,1 * g/dl
V.C.M. : 110,0 * fl
H.C.M. : 38,8 * ug
C.H.C.M. : 35,3 g/dL
R.D.W. : 15,6 o/o
Plaquetas : 77 * mil/ul
INR : 3,33 * 0,50 - 1,50
Tiempo de Protrombina % : 22 * o/o
Tiempo de Protrombina seg : 40,9 seG
TTPA (seg) : 60

Glicemia : 95 mg/dl
Creatinina : 1,20 mg/dl
Fosfatasa Alcalina : 116 U/L
Bilirrubina Indirecta : 4,72 * mg/dL
Bilirrubina Directa : 5,98 * mg/dL
Bilirrubina Total : 10,70 * mg/dL
ASAT/GOT : 76 * U/L
ALAT/GPT : 40 U/L
Gama GT : 30 U/L
Clearence Calculado(MDRD) : 65,47 ml/min/1,73 |
Proteina C Reactiva : 19,7 * mg/L
Nitrógeno Ureico : 11 mg/dL
Uremia : 24 mg/dl

LUIS MERA SALTOS
MEDICO TRATANTE
21510269-6

JEFE SERVICIO